3.1.8 한방서비스			
규 정 번 호	3.1.8	제 정 일	3주기 규정집 제정
관 련 인증기준	3.1.8 한방서비스	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	한방진료과	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 의료법 및 의료법 시행규칙 2. 폐기물관리법 3. 한의원·한방병원 감염관리표준예방지침(보건복지부)		

▣ 목적 (Purpose)

한방 시술을 안전하게 수행함으로써 시술 시 발생할 수 있는 감염, 화상 및 이상반응 등의 위험으로부터 환자 또는 직원의 건강을 보호하고, 관련 시설을 위생적으로 관리한다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 한방서비스 : 질병 치료를 위해 환자에게 침(鍼)술, 구(灸)술, 부항요법 등을 실시하는 것을 의미한다.
- 침술요법 : 침으로 체표상의 혈(穴)들을 자극하여 병을 예방하거나 치료하는 방법
- 자침(刺針) : 침을 놓음, 발침(拔針) : 침을 뽑음, 유침(留針) : 침을 놓고 계속 유지
- 호침요법 : 임상에서 가장 일반적으로 상용되는 침요법으로 길이 30mm 굵기 0.20mm의 침이 주로 쓰임

▣ 정책 (Policy)

1. 한방 서비스에 대한 규정이 있다.
2. 한방 서비스를 안전하게 제공한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

1. 일반적인 처방

가. 한방 처방의 필수요소

1) 환자정보
2) 처방내용
3) 처방일자/시간
4) 처방 의사명

2. 환자확인 절차

[1.1 정확한 환자 확인 및 의사소통] 규정에 따라 이름과 등록번호(또는 주민등록상 생년월일)를 환자 본인에게 직접 질문하여 확인한다.

가. 환자확인 방법

1) 모든 한방 처치 시작 전 개방형 질문으로 환자명을 확인한다.
2) 환자인식밴드의 환자명과 등록번호(또는 생년월일)와 환자가 답변한 환자명과 등록번호(또는 생년월일)이 일치하는지 확인한다.

3) 환자가 의식이 없거나 답변이 불가능한 경우 보호자가 있을 경우 보호자에게 개방형 질문으로 환자명과 등록번호 또는 주민등록상 생년월일을 확인하고 보호자가 없을 경우 직원 2인이 동시에 확인하여 정확한 환자 확인을 실시한다.

3. 한방 진료의 종류와 내용

가. 침

1) 침 종류와 시술절차

가) 호침(豪鍼) 요법

(1) 임상에서 가장 일반적으로 상용되는 침요법이다. 머리카락 정도의 가는 침으로 길이 30mm, 굵기 0.20mm의 호침이 주로 쓰인다.

(2) 준비물 : 1회용 침, Alcohol sponge, 침관(필요에 따라), Tray

(3) 시술절차

(가) 환자에게 목적과 방법을 설명한 후 물품을 가지고 간다.

(나) 시행할 부위를 노출시킨 채 환자로 하여금 알맞은 체위를 취하게 한다.

(다) 혈위를 선택하여 신속하게 피부에 자침하고 제삽, 염전 등 자침의 운용기법이 끝난 후 적절히 유침시킨다.

(라) 유침시간 동안 환자의 체위를 일정하게 유지하여 침이 굽거나 절단되지 않도록 유의한다.

(마) 환자상태를 관찰하여 안면창백, 현훈 등의 증상이 있거나 자침부위 출혈 혈종 등이 나타나면 즉시 한의사에게 보고하여 발침 하도록 한다.

(바) 발침 후 alcohol sponge로 침공 부위를 닦아주며 출혈이 있을 때는 멎을 때까지 눌러준다.

(사) 발침이 끝나면 남아있는 침이 없는지 자세히 살펴본 후 환자가 옷을 입도록 돕는다.

(아) 사용한 1회용 침은 손상성 의료폐기물 전용용기(합성수지류)에, 알코올솜(Alcohol sponge)은 일반의료폐기물 전용용기에 각각 분리하여 배출하여 처리한다

(4) 적응 : 각종 급·만성 질병

(5) 금기

(가) 극도의 피로, 기아상태, 고도의 긴장상태

(나) 피부상의 감염, 반흔, 부종·동통(통증)이 있는 부위

(다) 출혈성 경향이 있거나 고도의 수종(水腫)환자

나) 전침(電鍼)요법

(1) 호침의 침자법에 따라 자입한 다음 전기와 침을 결합하여 직류 전기를 통전시키거나 저주파전기를 통전시켜 혈위의 자극을 강하게 하는 치료방법이다.

(2) 준비물 : 전침기, 호침 준비물

(3) 시술절차

(가) 호침요법으로 자침한다.

(나) 득기한 후 전침기의 전류 다이얼을 0으로 조절하여 같은 쪽의 지체에 꽂은 2개의 침병(침자루)에 전침기의 출력 cord를 연결시킨다.

(다) 전원스위치를 켜고 적당한 파장을 선택한다.

(라) 점차적으로 출력 전류량을 높여서 필요한 정도에 이르게 한다. (전류량의 크기는 환자의 상태에 따라 결정하되 증가도는 환자가 견딜 수 있을 정도까지 한다.)

(마) 통전 과정 중 환자 상태를 관찰하며 전선이 탈락되지 않도록 유의한다.

(바) 통전 시간은 일반적으로 5~20분이다.

(사) 통전이 끝나면 전류 조절기를 0으로 하고 전원스위치를 끈 다음 출력을 제거한다.

(아) 호침 발침법과 동일한 방법으로 한다.

(자) 환자에게 침 시술을 할 경우 환자 모식도에 해당 시술 사항을 기록하여 발침 누락을 예방한다.

(4) 적응 : 각종 통증, 중풍후유증으로 인한 마비나 위축, 장기 기능실조, 침자 마취

(5) 금기 : 금기는 없으나 심장질환 환자에게 신중히 사용한다.

2) 소독 및 멸균

가) 침 포장을 제거하고 나서 삽입에 앞서 침자루나 침 끝을 만지지 않아야 한다.

나) 침은 반드시 1회용 침을 사용하여야 하며, 재사용해서는 안 된다.

다) 사용 전의 멸균된 1회용 침은 밀봉된 상태로 멸균 상태가 잘 유지되도록 관리에 유의하여야 한다.

라) 환자의 시술 부위는 시술 전에 깨끗이 세척하여야 하고, 알코올 솜이나 피부소독제를 이용하여 소독하여야 한다.

마) 시술 시에는 무균술의 원칙을 준수하여 멸균된 침이 멸균, 소독된 시술 부위에만 접촉할 수 있도록 주의한다.

바) 소독한 후 소독부위를 만지지 않는다.

사) 침관은 시술 전에 멸균 되어야 한다. 침관은 같은 환자에게는 반복적으로 사용 할 수 있으나 다른 환자에게 사용할 때는 교체해야 한다.

아) 사용한 침은 버릴 때까지 반드시 분리 보관하여야 하며 봉투에서 개봉한 침은 사용 후 남더라도 폐기한다.

3) 주의사항

가) 침 삽입부위를 만져 보아 동통이 있나 확인한다.

나) 원인 불명의 발열, 전신 및 국소 염증 소견이 있는지 살펴본다.

다) 침 삽입부위를 만져서 동통이 있는지를 알 수 없을 때에는 일일 1회 침 삽입 부위를 육안으로 관찰한다.

라) 시침 부위는 상처가 없어야 한다. 만약 신체부위가 거칠고 더럽다면 비누와 물로 씻어내고 알코올로 닦아내야 한다.

마) 발침 시에는 발침 부위를 알코올로 충분히 닦아 소독한다.

바) 금침 환자 : 술 취한 사람, 감정이 격한 상태에 있는 사람, 심하게 피로한 사람, 배부르거나, 배고프거나, 갈증이 심한 사람, 몹시 수척한 사람, 대출혈 후, 땀을 많이 흘린 후, 설사 후, 임산부, 저혈압, 심한 당뇨병 환자

사) 진료 및 처치 시 환자가 수치심을 느끼지 않도록 배려하고 스크린이나 침상간 커튼 등을 이용하여 신체노출을 보호해야 한다.

아) 발침 시 발침 누락 예방을 위하여 환자처치 모식도에 자침부위를 표시하고 자침과 발침의 개수를 정확히 확인 하여 기록 하고 발침한다.

4) 부작용 발생 시 대처방안

가) 침훈(鍼暈)

(1) 증상 : 침을 맞은 후 또는 도중에 환자의 안색이 창백하고, 땀을 많이 흘리거나, 가슴이 두근거리거나 답답하며, 머리가 어지러우며, 눈에 별이 반짝이거나, 메스꺼움, 구토가 나타나고 손발이 무겁고 찬 증상 등이 나타난다. 심한 경우는 정신이 혼미하며 쓰러지고, 입술과 손톱이 파래지며, 대 · 소변을 지리는 경우도 있다.

(2) 원인 : 환자의 체질이 허약하고, 정신의 과도한 긴장이 원인이 되는 경우 있고, 금침환자를 시술할 경우, 침시술기법이 과격한 경우 등이 원인이 되기도 한다.

(3) 대처방안 : 곧 발침하고 공기유통이 잘 되는 곳에 반듯이 눕히고, 옷이나 허리띠를 풀어준다. 가벼운 경우는 따뜻한 물을 마시게 하면 풀린다. 환자가 의식을 회복하면 30분 내지 한시간정도 휴식하게 하고 체력이 허약하고 중증인 경우에는 장시간 휴식하게 한다. 특히 앉은 자세에서 침훈의 기미가 보일 때는 즉시 눕게 해서 쓰러지는 것에 대비한다.

나) 출혈 시 적은양의 출혈이나 침자리의 작은 청반은 자침시 작은 혈관을 터뜨려서 생기는데 일반적으로 처치하지 않아도 자연히 없어진다. 만약 활동하기 불편한 경우에는 Alcohol sponge로 지혈하고, 지혈이 된 후에는 문질러 주거나 따뜻하게 해서 어혈이 풀어지게 한다.

다) 전침(電鍼) 부작용 및 대처방안

(1) 근육의 과도한 수축 및 경련이 일어 날수 있으며 전침기기의 전원을 즉시 차단하며 발침 후 안정을 취한다.

(2) 전극 부위에 화상을 입을 수 있으며 즉시 전침기기의 전원을 차단 후 피부상태를 확인하고 물집이나 피부손상 확인 시 담당의에게 즉시 알려 진료를 받도록 한다.

나. 전자뜸(기기구술)

1) 준비물과 시술 절차

가) 준비물 : 전기식 온구기, 알코올 솜

나) 시술절차

(1) 환자에게 목적과 방법을 설명한 후 물품을 침상 근처로 가지고 간다.

(2) 시행할 부위를 노출 시킨 채 환자를 편안한 체위로 눕힌다.

(3) 알코올 솜으로 시술 부위를 소독한다.

(4) 온구기의 선단부를 시술하고자 하는 부위에 가볍게 접촉한다.

(5) 가온스위치를 누르면 삑 하는 동작음과 함께 0.5 - 1초이내의 자극이 가해진다.

(6) 시술하는 환자가 바뀔 때마다 온구기의 선단부(접촉부분)를 알코올 솜으로 닦아 소독한다.

2) 주의사항

가) 피부가 약한 부분에는 사용하지 않는다.

나) 같은 부위에 연속해서 반복 사용할 경우 피부에 염증을 일으키거나 화상의 우려가 있으므로 반복 사용을 하지 않는다.

다) 중도의 고혈압 환자, 부정맥, 천식, 온도감각을 상실한 사람, 열에 의한 자극이 느껴지지 않는 사람, 당뇨병 등에 의한 고도의 말초순환장애에 의한 지각장애가 있는 사람, pacemaker를 장착한 사람, 저온화상을 입은 적이 있는 사람 등에게는 주의한다.

라) 뜸 금기 환자 : 실증, 열증, 음허발열과 얼굴, 대혈관과 점막부근, 임부의 흉복부와 요저부 등은 시구에 적합하지 않다.

3) 부작용 발생 시 대처방안

가) 전자뜸은 피부에 1초 이내 접촉하여 시술 하기에 부작용은 거의 없으나 드물게 피부 발적 및 피부 자극이 발생 할 수 있다.

나) 증상으로는 붉어짐, 가려움, 따끔거림이 있으며 대부분 30분 내 자연 회복되나 증상 지속 시 냉찜질을 시행하여 대처한다.

다. 부항요법

1) 건식부항(체표에 부항컵을 붙이고 나서, 일정 시간 후에 떼어내는 것)

가) 준비물 : 1회용 부항컵, 부항기, 알코올 솜

나) 시술절차

(1) 시술 부위를 확인하고 소독한 후, 1회용 부항컵을 부항기를 이용하여 부착시키고 유지시킨다.

(2) 환자가 통증을 느끼지 않을 정도로 압력을 주고, 통증 호소 시 압력을 조금 빼준다.

(3) 1회용 부항컵을 제거한 후, 해당 부위를 소독한다.

(4) 사용한 1회용 부항컵과 알코올 솜은 의료폐기물 전용 용기에 버린다.

2) 소독 및 멸균

가) 건식부항을 시행 시 1회용 부항컵을 사용한다.

나) 환자의 시술 부위는 시술 전에 알코올 솜이나 피부 소독제를 이용하여 소독하여야 한다.

다) 시술 시에는 무균술의 원칙을 준수하여 멸균된 부항이 멸균, 소독된 부위에만 접촉할 수 있도록 주의한다.

라) 소독한 후 소독 부위를 만지지 않는다.

3) 주의사항

가) 부항 부착 부위를 만져보아 동통이 있는지 확인한다.

나) 부항 부착 부위를 만져서 동통이 있는지를 알 수 없을 때에는 일일 1회 부항 부착 부위를 육안으로 관찰한다.

다) 원인 불명의 발열, 전신 및 국소 염증 소견이 있는지 살펴본다.

라) 부항 요법을 행하는 의료종사자는 과도한 흡착 시 공기 압력으로 인한 수포가 발생할 수 있으므로, 적당한 압력을 사용한다.

4) 부작용 발생시 대처방안

가) 부항 후 멍이나 출혈등이 발생 할수 있으나 대부분 자연스럽게 사라지지만 출혈이 멎지 않을 경우 담당의에게 연락하여 관련 약을 복용하는지 확인한다.

나) 부항으로 인한 피부자극으로 가려움이 발생할 수 있으나 시일내로 소실되므로 환자의 반응을 관찰한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 한방처치 모식도
2. 전자침 및 전자뜸 의료기기 일상 점검표

▣ 규정 개정일 [누적]

2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

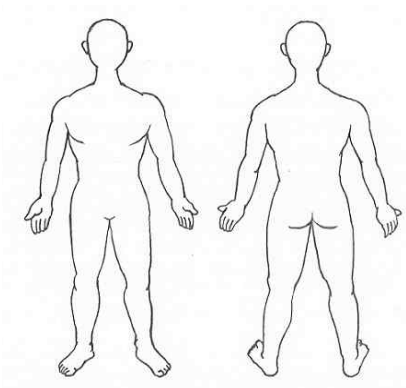
승 인 책 임 자	병 원 장	이름	이 진 희	서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 한방처치 모식도

한방처치 모식도

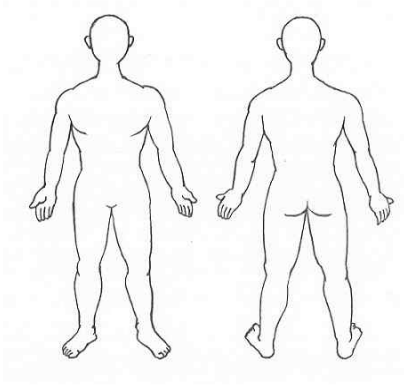
20 년 월 일

병실		이름		등록번호	



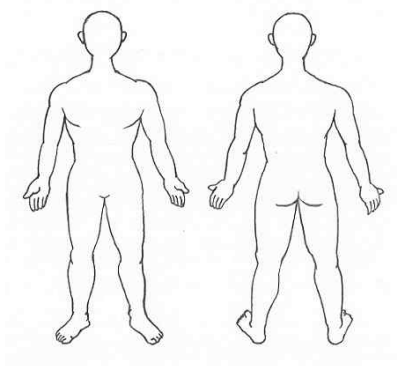
☐ 정확한 환자확인
☐ 손위생
☐ 신체노출보호
☐ 자침 : 개
☐ 발침 : 개
☐ 전침 : 개
☐ 전자뜸: 개
☐ 부항: 개

병실		이름		등록번호	



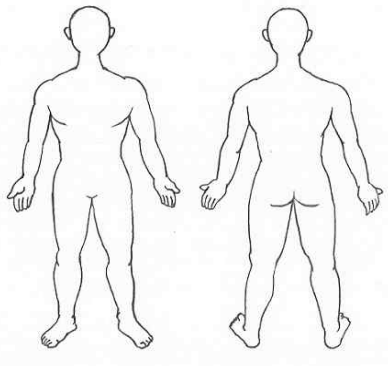
☐ 정확한 환자확인
☐ 손위생
☐ 신체노출보호
☐ 자침 : 개
☐ 발침 : 개
☐ 전침 : 개
☐ 전자뜸: 개
☐ 부항: 개

병실		이름		등록번호	



☐ 정확한 환자확인
☐ 손위생
☐ 신체노출보호
☐ 자침 : 개
☐ 발침 : 개
☐ 전침 : 개
☐ 전자뜸: 개
☐ 부항: 개

병실		이름		등록번호	



☐ 정확한 환자확인
☐ 손위생
☐ 신체노출보호
☐ 자침 : 개
☐ 발침 : 개
☐ 전침 : 개
☐ 전자뜸: 개
☐ 부항: 개

부록2. 전자침 및 전자뜸 의료기기 일상점검 일지

전자침 및 전자뜸 의료기기 일상 점검표

범례 : 양호(O), 불량(X)

사용부서		점검년월	년 월 일	의료기기담당자	(인)

품명		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
전자침-1	전원상태																															
	전류출력 상태																															
	디스플레이 표시상태																															
	케이블 정리상태																															
전자뜸-1	전원상태																															
	배터리충전 상태																															
	온도 적정 상태																															
	파손여부																															
확인자																																

조치 및 특이사항